Nome do Documento:	**PROTOCOLO DE REGULAÇÃO ELETIVA DE AUTORIZAÇÃO DE PAAF (PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA) E BIÓPSIAS AMBULATORIAIS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARAGUARI**		
Data da Emissão:	13/02/2025	**Tipo de Documento:**	Procedimento Operacional
Emitido Por:	Natalia Luiza Alves	**Revisado Por:**	Ana Carolina Naves Peixoto Vanessa Barbosa Andrade Denise Máximo Gonçalves Marislene Pulsena da Cunha Nunes
Aprovado Por:	Thereza Christina Griep	**Nº Revisão:**	Emissão Inicial

1. OBJETIVOS

Este protocolo visa regulamentar a solicitação e autorização da PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA (PAAF) e biópsias ambulatoriais na rede de saúde de Araguari, assegurando o acesso adequado ao diagnóstico de lesões suspeitas, como nódulos ou massas, promovendo a precisão diagnóstica para condições como câncer e doenças benignas. O objetivo é proporcionar uma abordagem eficiente, em conformidade com as diretrizes do Ministério da Saúde, e otimizar os recursos para um atendimento equitativo.

2. FORMULÁRIOS DE SOLICITAÇÃO

As solicitações de PAAF e biópsias ambulatoriais devem ser realizadas por meio do formulário padronizado conforme instrumento de registro SIGTAP, quando o serviço estiver disponível no município. Na ausência de prestadores habilitados localmente, será preenchido o Tratamento Fora do Domicílio (TFD), com o devido cadastro da solicitação no sistema FastMedic da UFU, assegurando o encaminhamento e o acompanhamento do paciente.

3. PROFISSIONAIS AUTORIZADOS A SOLICITAR O EXAME

Clínica Médica; endocrinologia; ginecologia e obstetrícia / mastologia; oncologia; pneumologia; cirurgia geral;

4. INDICAÇÕES (por Sítio de Realização)

A Punção Aspirativa por Agulha Fina (PAAF) e as Biópsias Ambulatoriais são indicadas para diagnóstico de massas ou nódulos em diversos locais, com base na avaliação clínica e exames de imagem realizados previamente. A seguir estão as indicações por sítio de realização:

a. Nódulos Tireoidianos

Nódulos suspeitos de malignidade (identificados por ultrassonografia ou avaliação clínica).

Nódulos sólidos ou mistas com características suspeitas.

Acompanhamento de nódulos tireoidianos previamente diagnosticados, quando há alteração nas características.

b. Nódulos Mamários

Nódulos palpáveis ou visíveis em exames de imagem (mamografia, ultrassonografia).

Pacientes com histórico de câncer de mama ou risco elevado.

Acompanhamento de nódulos benignos previamente diagnosticados.

c. Nódulos Pulmonares ou Massa Torácica

Lesões pulmonares visíveis em tomografia de tórax ou radiografia.

Acompanhamento de lesões previamente diagnosticadas com características suspeitas.

Avaliação de massas torácicas com suspeita de malignidade (neoplasias primárias ou metastáticas).

4.4 Linfonodomegalia

Linfonodos suspeitos (aumento persistente ou com características anormais, identificados por exames clínicos e de imagem).

Avaliação de linfadenopatias em pacientes com histórico de doenças infecciosas ou neoplásicas.

4.5 Lesões Abdominais e Retroperitoneais

Massas no fígado, pâncreas, baço ou rins.

Nódulos ou lesões que não são acessíveis por outros métodos de biópsia.

4.6 Lesões Orais ou Maxilofaciais

Nódulos ou massas na região bucal, maxilar ou mandibular, suspeitas de neoplasias.

5. CONTRAINDICAÇÕES

Coagulopatias ou trombocitopatias graves (riscos hemorrágicos elevados).

Nódulos de difícil acesso (localização que impede a realização segura da punção, como perto de vasos importantes).

Infecções locais: Quando a área da punção apresenta infecção ativa ou celulite, a PAAF/biópsia não deve ser realizada até a resolução do quadro infeccioso.

Pacientes não colaborativos: A PAAF/biópsia requer a cooperação do paciente para imobilização e segurança do procedimento, especialmente em áreas de difícil acesso.

6. CRITÉRIOS DE PRIORIDADE

Vermelho (Alta Prioridade): Pacientes com suspeita clínica ou de imagem de neoplasias malignas.

• Nódulos com características altamente suspeitas de malignidade.

Laranja (Prioridade Muito Alta): Pacientes com alto risco de complicações ou que necessitam de diagnóstico imediato devido a suspeita de malignidade, mas com características menos evidentes de agressividade.

• Pacientes com histórico recente de neoplasias ou sintomas sugestivos de malignidade (ex: rápido crescimento de nódulos, dor persistente).

Amarelo (Prioridade Moderada): Pacientes com histórico familiar de câncer, com nódulos de risco intermediário (por características de imagem).

• Nódulos com características suspeitas, mas sem urgência imediata.

Verde (Baixa Prioridade): Pacientes sem histórico de doenças malignas e sem comorbidades graves.

• Nódulos benignos ou suspeitos de baixa malignidade. Exame não urgente, pode ser realizado em até 30 dias.

Azul (Prioridade Mínima): Pacientes sem qualquer indicação de malignidade, com nódulos benignos e que não apresentam sintomas preocupantes.

• Exames programados de baixo risco, podendo ser realizados em prazos mais longos.

7. CRITÉRIOS DE NÃO CONFORMIDADE

Solicitação incompleta, incorreta e/ou ilegível, sem a devida documentação de exames de imagem (ultrassonografia, mamografia, etc.).

Indicação inadequada para a realização do procedimento, sem justificativa clínica ou radiológica clara.

Falta de avaliação clínica prévia, com ausência de histórico do paciente, como uso de medicamentos anticoagulantes, doenças pré-existentes ou histórico de câncer.

Falta de informações sobre a condição do paciente: Necessário registrar com clareza o risco clínico do paciente para o procedimento (ex.: comorbidades, alergias).

8. VIGÊNCIA DA SOLICITAÇÃO

As solicitações terão validade de 90 (noventa) dias, para recebimento na Central de Regulação Eletiva, contados da data de emissão, devendo ser reavaliadas após esse período.

9. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ministério da Saúde. (2018). Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas para Câncer de Mama. Brasília: Ministério da Saúde. Disponível em: www.saude.gov.br

Nome e Função	Assinatura
Thereza Christina Griep **Secretária Municipal de Saúde**	THEREZA CHRISTINA GRIEP:00146934024 Assinado de forma digital por THEREZA CHRISTINA GRIEP:00146934024 Dados: 2026.05.13 11:34:40 -03'00'
Vanessa Barbosa Andrade **Gerente de Atenção Integral à Saúde**	gov.br Documento assinado digitalmente VANESSA BARBOSA ANDRADE Data: 19/05/2026 13:03:42-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Ana Carolina Naves Peixoto **Médica Reguladora**	gov.br Documento assinado digitalmente ANA CAROLINA NAVES PEIXOTO Data: 15/05/2026 15:50:28-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Marislene Pulsena da Cunha Nunes **Coordenadora da Atenção Primária em Saúde**	gov.br Documento assinado digitalmente MARISLENE PULSENA DA CUNHA NUNES Data: 17/05/2026 00:41:14-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Denise Máximo Gonçalves **Coordenadora da Central de Regulação Eletiva Municipal**	gov.br Documento assinado digitalmente DENISE MAXIMO GONCALVES Data: 13/05/2026 12:13:03-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Natalia Luiza **Enfermeira Referência Técnica - CRE**	gov.br Documento assinado digitalmente NATALIA LUIZA ALVES Data: 13/05/2026 13:19:59-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br